续表

上肢骨折和脱位 ★★☆（0~3 题）			
	桡骨头半脱位（2012）	前臂骨折和脱位（2014、2020）	桡骨远端骨折（2007、2014）
好发部位			
好发年龄	＜ 5 岁“饶了我不”		中老年骨质疏松
分型移位			伸直型 /Colles 常见：手掌着地，远折端向桡背侧 屈曲型 /Smith：手背着地，远折端向桡掌侧 Barton 骨折：桡骨远端关节面骨折伴腕关节脱位 “come 手背离得远、stop 手掌离得远”
临床表现	手、腕被动向上牵拉史 X 线唯一阴性的脱位		Colles、多数 Barton： 正位呈枪刺刀、侧位呈银叉畸形 “正面拼刺刀”
合并损伤		Galeazzi 骨折：桡骨干下 1/3 骨折 + 尺骨头脱位“桡下痒痒” Monteggia 骨折：尺骨干上 1/3 骨折 + 桡骨头脱位“痴人说梦”	
保守治疗	不用麻醉即手法复位 不可暴力牵拉以免复发 复位后不需固定 “三个不”	前臂双骨折 需解剖复位（对位对线均好）、注意防止畸形和旋转 先复位稳定骨折如横形骨折 均为不稳定骨折：下段先复位桡骨、中上段先复位尺骨 8~10 周 X 线证实骨折已愈合才进行前臂旋转功能锻炼 “九转大肠”	手法复位 + 外固定 （Colles- 屈腕尺偏位石膏）
手术治疗			